SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de **Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c.c indenização por danos morais** intentada pela menor impúbere **M.C.T.R.M.,** representada por sua genitora, **JULIANA TIMES RIBEIRO MONTENEGRO**, através de advogada devidamente constituída (ID 105305619), em face da **AMIL Assistência Médica Internacional S/A**, ambos devidamente qualificados, na qual pretende compelir a ré a fornecer os medicamentos: **1) Leuprorrelina** 3,75mg, 1FA/mês, com aplicação de 1amp por via intramuscular a cada 28 dias, uso contínuo; e **2) Somatropina** – na dose de 12mg (ou 15mg), 4amp/mês, ou na dose de 10mg, 5amp/mês, ou na dose de 20mg, 3amp/mês – com aplicação de 1,7mg por via subcutânea à noite, uso contínuo, a título de tutela antecipada de urgência, além de, no mérito, pugnar pela confirmação da obrigação de fazer e condenação da ré a indenizar danos morais.

Para tanto a parte autora aponta que foi diagnosticada com baixa estatura idiopática (CID 10: E34.3), além de ter desenvolvido puberdade central, está com aumento progressivo de mama (M3) e avanço da idade óssea (12 anos de idade óssea), com necessidade do tratamento medicamentoso supra referido, prescrito pela endocrinologista pediátrica Barbara Guiomar Sales Gomes, CRM 13053 (ID 105305627), devendo ser iniciado o quanto antes, anteriormente a primeira menstruação, até porque a puberdade se aproxima e a paciente não atingiu a altura alvo familiar.

Informa que os genitores da autora entraram em contato com a operadora, recebendo a negativa do fornecimento do tratamento, sob argumento de que tais medicações não são padronizadas nas Unidades Amil Espaço Saúde, e receberam a orientação de agendar atendimento com especialistas da Amil (ID 105305626).

Frustradas as tentativas de agendamento especializado junto a ré, a parte autora enviou notificação extrajudicial à Amil narrando os fatos e reiterando a necessidade urgente do tratamento (ID 105307382), ao que adveio a negativa aos medicamentos solicitados, sob o fundamento de que são realizadas em regime ambulatorial, sem cobertura obrigatória pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS (Rol da ANS).

Argumenta que o tratamento medicamentoso prescrito à autora – hormônio do crescimento HGH) – consta no Rol da ANS (ID 105305630, pág.87), bem como a Nota Técnica nº 335/2014, do Ministério da Saúde, cita aprovação pela Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) para as hipóteses de baixa estatura idiopática (ID 105305631).

Assim, a negativa da seguradora é abusiva e ilegal, não podendo a menor ficar privada da medicação, que é de uso contínuo e de início imediato, pois corre o risco de a menor não recuperar a estatura, o que lhe acarretará diversos problemas em sua vida pessoal, desenvolvimento psicoemocional, como problemas de interação social, retraimento, ansiedade, comportamento agressivo e baixa autoestima, conforme atestado pela endocrinologista assistente (ID 105305627).

Diante do narrado, **requer a concessão de tutela antecipada** para compelir a ré a fornecer o tratamento medicamentoso (**Leuprorrelina** e **Somatropina**), nos moldes prescritos pela especialista no ID 105305627.

No mérito, pugna pela condenação da ré a pagar indenização no montante de R$ 10.000,00, sendo este o valor dado à causa e sobre qual procedeu o recolhimento das custas (ID 105348891). Ademais, manifesta desinteresse em audiência de conciliação (art.334 CPC/2015).

Decisão interlocutória de ID 105471959 indefere o pedido de antecipação de tutela e ordena a citação da ré para ofertar contestação.

A parte demandada oferece contestação (ID 107013062), invocando o seguinte: (i) os medicamentos prescritos – somatropina e leuprorrelina- não possuem cobertura obrigatória de acordo com o rol da ANS e com os termos contratuais, que expressamente exclui de cobertura os medicamentos e procedimentos que não integram o rol;(ii) os medicamentos ambulatoriais que devem ser fornecidos pelas operadoras estão definidos nos art. 17 e 18 da RN 465 de 2021; (iii) inexistência de danos morais, ante a licitude da conduta da operadora de saúde.

Postula, ao término, pela improcedência dos pedidos atriais, com condenação da autora nos ônus da sucumbência.

A parte autora informa a interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela – **AI 10912-08.2022.8.17.9000**, requerendo o juízo de retratação (ID 107767436).

Réplica ofertada no ID 109450040.

Decisão de ID 121383387 mantem a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos e determina a intimação das partes para indicarem provas a produzir, no prazo comum de 15 dias.

Por derradeiro, determinada vista dos autos ao MP, em razão da existência de interesse de incapaz.

A parte autora requer o julgamento antecipado da lide (ID 124130620). A operadora de saúde, por seu turno, também informa não ter provas a produzir (ID 123724600).

Parecer Ministerial opina pela procedência da ação e fornecimento da medicação prescrita à autora, pelo tempo que for necessário, enquanto durar o tratamento, conforme indicado no laudo médico. (ID 132096007)

Vieram-me conclusos.

É o que se tem a relatar. Passo a analisar e decidir.

A questão controvertida nos presentes autos dispensa dilação probatória, uma vez que os elementos presentes, inclusive a prova documental, já são suficientes para emitir a sentença antecipadamente, conforme autoriza o art.355, inciso I, do CPC/2015. Ademais, a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide e a ré não requereu provas.

À partida, cumpre destacar que os contratos de seguro, por definição legal, encerram relação de consumo, portanto devem ser interpretados sob a ótica da legislação que lhe é própria, ainda que definidos ou regulamentados em textos outros.

Tal entendimento foi ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) através do enunciado da **Súmula 608**: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*" (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

Nas relações de consumo, notadamente aquelas que se firmam mediante simples adesão de uma parte ao contrato previamente estabelecido pela outra, devem preponderar, sobre a letra fria do texto, a boa-fé dos contratantes e o equilíbrio contratual, ressaltando-se que a finalidade precípua do contrato de assistência médica entabulado com a ré é a manutenção da saúde da contratante.

A questão fulcral para apreciação reside em identificar se o **fornecimento de medicamento para uso domiciliar** é ou não serviço de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, de conformidade com a legislação de regência, especificamente a Resolução Normativa 465/2021 da ANS.

De início, merece registro que os medicamentos ora solicitados se reportam ao hormônio do crescimento e puberdade precoce, a serem ministrados **fora** do regime de internação hospitalar ou de atendimento ambulatorial de urgência ou de emergência. Para além disto, não se cuidam de medicações quimioterápicas oncológicas ou tratamento de neoplasia maligna, como igualmente não haverá internação domiciliar em substituição à internação hospitalar.

Assim, diante do panorama fático descortinado, com esteio na própria prova colacionada aos autos pela parte autora, constata-se que em se tratando de medicamentos ministrados fora do regime de internação hospitalar ou ambulatorial, não versando sobre tratamento de neoplasia ou quimioterapia oncológica, a exclusão de cobertura encontra suporte no art. 10, inciso VI da Lei 9.656/98:

> Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigência mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, **exceto**:
>
> VI – fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;

Para além disto, preconiza a Resolução Normativa 465/2021 da ANS:

> Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida

no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.
Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:
(...)
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;

Neste ser assim, há cobertura para medicamentos de uso domiciliar apenas no que tange a quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento de câncer (inciso IX), bem como medicamentos antineoplásicos orais, como dispõe o inciso X, ambos do art. 18, da RN em relevo.

Deste modo, à luz desses dispositivos normativos, depreende-se que **é lícita a exclusão de medicação para tratamento domiciliar convencional**, já que a obrigatoriedade de fornecimento pelos planos de saúde externamente à unidade de saúde está restrita aos medicamentos antineoplásicos/quimioterápicos em tratamento oncológico.

Assim, a recusa pelo plano de saúde de custeio de medicamento – hormônio do crescimento/bloqueador de puberdade – para fins de tratamento terapêutico, não configura abusividade, até porque o medicamento receitado para o caso concreto não é serviço essencial à natureza do contrato de assistência à saúde, cuidando-se, em real verdade, de serviço excepcional, adicional.

Ademais, conquanto o laudo da endocrinologista assistente ateste a necessidade do tratamento, não se tratam de medicações prescritas como sendo essenciais para manutenção/preservação da vida/saúde/sobrevivência da paciente, ou seja, não se infere dos termos ali expressos risco vital a lastrear a excepcionalidade da pretensão.

Nesse sentido, destaco julgados do TJPE:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. **TRATAMENTO. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES. MEDICAMENTO DOMICILIAR. NÃO OBRIGATORIEDADE PELA ANS. RECURSO NÃO PROVIDO**. 1.1. **Em regra, o plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamentos de uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (*home care*) e outros fármacos incluídos pela ANS no rol de fornecimento obrigatório**. 2. **Segundo o STJ "*lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar*", isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (*home care*) e os incluídos no rol da ANS para esse fim**. 3. Recurso não provido. Decisão unânime. (APELAÇÃO CÍVEL 0110047-72.2021.8.17.2001, Rel. ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC), julgado em **28/03/2023**, DJe)
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. **NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DOMICILIAR. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RISCO À VIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE**. 1. Nos casos de urgência e emergência, em que o risco à vida se revele presente, admite-se interpretação extensiva do art. 10, VI, da lei 9.656/98 – que exclui da cobertura assistencial mínima o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar - para abranger o medicamento ministrado por orientação do médico assistente fora do regime de internação hospitalar, levando-se em conta a natureza do contrato de plano de saúde e a sua finalidade precípua de proteção à vida e à saúde do contratante. 2. **Hipótese em que o tratamento medicamentoso pleiteado não se apresenta como terapia fundamental para a vida do paciente, mormente porque o laudo do médico assistente justifica a urgência do início do tratamento com o hormônio do crescimento tão somente no fato de a menor ficar com "altura final muito abaixo do padrão populacional feminino e genético"**. 3. Apelação a que

se dá provimento. (APELAÇÃO CÍVEL 0000272-59.2020.8.17.2001, Rel. FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC), julgado em **31/08/2022**, DJe)

EMENTA – SEGURO SAÚDE. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (SOMATROPINA). MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTS. 10, VI E 12, I, 'c' e II, 'g' DA LEI Nº 9.656/98 E NO ROL DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 428/2017 DA ANS, TAMPOUCO EM PARECERES TÉCNICOS SOBRE MEDICAMENTOS E/OU MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. FORNECIMENTO. NÃO OBRIGATORIEDADE. NEGATIVA COM BASE CONTRATUAL E NORMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

Não configurada abusividade ou ilegalidade na conduta da seguradora apelada ao recusar a cobertura do custeio do medicamento SOMATROPINA, de uso domiciliar, fora do ambiente hospitalar e ambulatorial, para o qual não está obrigada por lei ou contrato, sendo legítima a conduta baseada em expressa exclusão contratual lastreada na excepcionalidade dos Arts. 10, VI e 12, I, 'c' e II, 'g' da Lei nº 9.656/98, bem como não fazendo parte do rol de procedimentos e eventos de cobertura obrigatória listados no anexo I da Resolução Normativa nº 428/2017, tampouco nas hipóteses de cobertura elencadas no PARECER TÉCNICO Nº 26/GEAS/ GGRAS/DIPRO/2018 e no recente PARECER TÉCNICO Nº 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 sobre MEDICAMENTOS, assim como nos mais recentes PARECERES TÉCNICOS Nº 29/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 e Nº 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 sobre os MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR.

Conquanto o laudo da médica assistente ateste a necessidade do tratamento precoce com a reposição hormonal da somatropina até a idade óssea de 16 anos, não se infere dos termos ali expressos risco vital a lastrear a excepcionalidade da pretensão, visando o tratamento melhorar a estatura do paciente à luz dos critérios da normalidade populacional e familiar. (TJPE - Apelação Cível nº 0028339-05.2018.8.17.2001, Rel. Des. ALBERTO NOGUEIRA VIRGÍNIO, 2ª Câmara Cível, julgado em 13/04/2021) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. **HORMÔNIO DE CRESCIMENTO. MEDICAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. PREVISÃO DO ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98.** RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Considerando que o medicamento não foi prescrito como sendo essencial para manutenção/preservação da vida do paciente, estando, ainda, dentro das previsões de exclusão contratual autorizadas por Lei, não se verifica a abusividade da negativa do plano de saúde. (TJPE – Apelação Cível nº 0046021-70.2018.8.17.2001, Rel. Des. STÊNIO NEIVA COELHO, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/11/2020).

Acrescente-se, no ponto, consoante julgado da 5ª Câmara Cível do TJPE, da lavra do Des. José Fernandes de Lemos, no bojo do Agravo de Instrumento nº 0013093-03.2017.8.17.2001, que "*não é razoável obrigar a operadora de saúde a fornecer ao agravado tratamento expressamente excluído da cobertura obrigatória, de eficácia não comprovada e em condições que ofendam o equilíbrio contratual e lhe ponham em situação de desvantagem excessiva*".

No ponto merece ser transcrita a ementa do julgado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FORNECIMETO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1.O fornecimento de medicamento para uso domiciliar (salvo para tratamento de neoplasias malignas) não é serviço de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos moldes do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e do art. 20, VI, da Resolução Normativa ANS

nº 387/2015.

2.Não fere o Código de Defesa do Consumidor a negativa de cobertura de hormônio de crescimento e bloqueador de puberdade para tratamento domiciliar de eficácia controversa na espécie. O aludido tratamento não se cuida de serviço essencial à natureza do contrato de assistência à saúde, não implicando em terapia fundamental para saúde/sobrevida/cura do paciente. Cuida-se de tratamento eletivo, cuja efetividade é duvidosa no caso do agravado, conforme parecer técnico fundamentado acostado aos autos.

3.Não é razoável obrigar a operadora de saúde a fornecer tratamento expressamente excluído da cobertura obrigatória, de eficácia não comprovada e em condições que ofendam o equilíbrio contratual e lhe ponham em situação de desvantagem excessiva.

4.Ausente os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), é de se indeferir a tutela de urgência, reformando-se a decisão originária que concedeu tal providência. (TJPE, Agravo de Instrumento 0003904-53.2017.8.17.9000, Relator Des. José Fernandes de Lemos, data julgamento: 03.10.2017).

No mesmo trilhar julgado do TJDF:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SEGURADO TITULAR. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL.

I. Aquele que contrata seguro privado de assistência à saúde é parte legítima para a causa que tem por objeto o fornecimento de medicamento a um de seus beneficiários.

II. Em se cuidando de medicamento ministrado fora do regime de internação hospitalar ou de atendimento ambulatorial de urgência ou de emergência, a exclusão contratual encontra suporte no artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, e da Resolução Normativa 387/2015 da ANS.

III. Recurso conhecido e provido. (TJDF, 4ª Turma Cível, Relator Des. James Eduardo Oliveira, data de julgamento: 11.10.2017).

É de se destacar, ainda, que os precedentes em que o STJ e demais tribunais tem entendido pela obrigatoriedade de fornecimento de medicamento pelo plano de saúde para uso domiciliar pelos consumidores, referem-se a circunstâncias diversas dos autos, como, por exemplo, **para tratamento de neoplasias malignas ou de doenças graves e crônicas** (a este respeito: AgInt no AREsp 918635; REsp 1641135/SP e AgRg no REsp 1541966/RS).

Deste modo, não tendo o plano de saúde a obrigação de fornecer os medicamentos vindicados, não há como acolher os pedidos de obrigação de fazer e nem em danos morais, já que não há conduta ilícita ou irregular praticada pela parte ré.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta **JULGO IMPROCEDENTE** a pretensão atrial, ao tempo que **extingo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC/2015.**

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, em sintonia com o art. 85, § 2º do CPC/15.

Após o trânsito em julgado, verificada a inércia da parte interessada, arquivem-se independentemente de nova conclusão.

Intime-se, também, o MP.

P.R.I.

Recife, 12 de maio de 2023.

Virgínia Gondim Dantas

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: VIRGINIA GONDIM DANTAS
12/05/2023 18:39:59
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 132923289

23051218395962700000129849039

IMPRIMIR GERAR PDF